TEMA 55 · Atención de enfermería a personas en situación de dependencia. Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Coordinación sociosanitaria

Resumen OPE Enfermería SMS · Ley 39/2006 y SAAD, principios, niveles de protección, grados, catálogo de servicios y prestaciones (RD 675/2023), cuidador no profesional, procedimiento (IMAS), BVD y EVE, Barthel, Katz, Lawton, MEC, Pfeiffer, Gijón, Zarit, Norton, Braden, coordinación en Murcia, gestora de casos y PAE

1. Ley 39/2006 y el SAAD

- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (**LAPAD**): el **«cuarto pilar del Estado del bienestar»**; desarrolla los **artículos 49 y 50 de la Constitución**; crea un **derecho subjetivo y universal**. Crea el **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)**, red pública con centros públicos y concertados.
- **Principios**: universalidad y equidad, atención integral (coordinación sociosanitaria), **permanencia en el entorno** (prioridad a quedarse en casa), participación de la persona y carácter público.
- **Niveles de protección**: **mínimo** (lo paga íntegramente el **Estado**), **acordado** (convenios Estado-comunidad, que aporta al menos lo mismo) y **adicional** (lo añade cada **comunidad**). Existe **copago** según la capacidad económica (**renta y patrimonio**; referencia IPREM).
- Definiciones (art. 2): **autonomía** = capacidad de **controlar y tomar decisiones propias** y realizar las ABVD; **dependencia** = estado **permanente** en que, por edad, enfermedad o discapacidad, se necesita la **ayuda de otra persona** para las **actividades básicas de la vida diaria (ABVD)**.

Grado	Necesidad de ayuda para varias ABVD	Puntos (BVD)
— (sin grado)	—	**0-24**
I. Dependencia moderada	**Al menos 1 vez al día** o apoyo intermitente	**25-49**
II. Dependencia severa	**2-3 veces al día**, sin apoyo permanente	**50-74**
III. Gran dependencia	**Varias veces al día** y **apoyo indispensable y continuo**	**75-100**

- Los **niveles** dentro de cada grado se **suprimieron**. Los grados se basan **solo en las ABVD**, no en las instrumentales.

2. Catálogo de servicios y prestaciones

- **Prioridad de los servicios** sobre las prestaciones económicas (estas son excepcionales).
- **Servicios**: **prevención y promoción de la autonomía**; **teleasistencia** (24 h); **ayuda a domicilio (SAD)**: tareas del hogar y **cuidados personales**; **centro de día y de noche** (también **respiro familiar**); **atención residencial** (permanente o temporal).
- Horas de **SAD** según el **RD 675/2023** (citadas en el manual): **grado I 20-37 h/mes**, **grado II 38-64 h/mes**, **grado III 65-94 h/mes**.
- **Prestaciones económicas**: **vinculada al servicio** (para pagar un centro privado acreditado si no hay plaza pública), **de asistencia personal** (contratar un asistente para una vida independiente) y **para cuidados en el entorno familiar** (cuidador no profesional; excepcional).
- **Incompatibilidades**: en general servicios y prestaciones no se combinan; la **teleasistencia es compatible con todo salvo la residencia**; la **residencia es incompatible** con SAD, centro de día y prestaciones.

3. El cuidador no profesional

- Requisitos: **mayor de 18 años**, residencia legal, capacidad física y psíquica, **no ser dependiente**, **parentesco hasta el 3.er grado** (padres e hijos 1.º; abuelos, nietos y hermanos 2.º; **tíos y sobrinos 3.º**; **los primos son 4.º**

grado: no valen), atención efectiva en un domicilio adecuado.
- **Convenio especial con la Seguridad Social** (formulario TA-0040): la Administración asume la cotización; cubre **jubilación e incapacidad permanente**, **no** desempleo ni incapacidad temporal.

4. Procedimiento (Región de Murcia: IMAS)

- **Solicitud** del interesado con el **informe de condiciones de salud** del médico de atención primaria → **valoración en el domicilio** por el equipo del **IMAS** (BVD o EVE) → **dictamen** → **resolución de grado** → **Programa Individual de Atención (PIA)** con los servicios sociales.
- **Plazo máximo para resolver: 6 meses** desde la solicitud; si se supera, hay **efectos retroactivos**.
- **Traslado** a otra comunidad: la de origen mantiene la prestación **60 días**.
- **Revisión del grado** (de oficio o a instancia del interesado) solo por: **mejoría o empeoramiento**, **error de diagnóstico o de aplicación del baremo**, o **cambio de situación** que obligue a cambiar el PIA (p. ej., fallece el cuidador).
- **Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD, RD 174/2011)**: a partir de **3 años**; **observación directa** del desempeño; **47 tareas en 10 actividades**; puntuación sobre 100 (**umbral: 25 puntos**). **Escala de Valoración Específica (EVE)**: **menores de 3 años** (0-35 meses); da **1, 2 o 3 puntos** = grado I, II o III.

5. Escalas de valoración geriátrica

- **Índice de Barthel (ABVD, 0-100)**: 10 actividades; **traslado cama-sillón y deambulación valen hasta 15**; comer, vestirse, deposición, micción, retrete y escaleras hasta 10; **baño y arreglarse 5**. **100 independiente** (90 en silla de ruedas); **≥ 60 leve**; **40-55 moderada**; **20-35 grave**; **< 20 total**.
- **Índice de Katz (ABVD)**: 6 funciones (baño, vestido, retrete, movilidad, continencia, alimentación) con letras **A (independiente) a G (dependiente en todas)**.
- **Lawton y Brody (AIVD, 0-8)**: teléfono, compras, comida, hogar, ropa, transporte, **medicación**, **dinero**; **8 = independiente**. Las **AIVD son las primeras que se pierden** en el deterioro cognitivo. Sesgo de género en algunos ítems.
- **MEC de Lobo** (adaptación del MMSE de 30 puntos): **35 puntos**; orientación, fijación, cálculo (restar de 3 en 3 desde 30), memoria diferida, lenguaje y construcción (copia de **pentágonos**); se **corrige por edad y escolaridad**; **≤ 23 = deterioro** (corte 23/24).
- **Pfeiffer (SPMSQ)**: 10 preguntas; **se cuentan los errores**: **0-2 normal**, **3-4 leve**, **5-7 moderado**, **8-10 grave**; se permite **1 error más si no tiene estudios** y **uno menos con estudios superiores**.
- **Escala sociofamiliar de Gijón**: 5 áreas (familia, economía, vivienda, relaciones, apoyos) de 1 a 5 (**5-25**); **> 15 = riesgo social alto**.
- **Zarit** (sobrecarga del cuidador): **22 ítems (22-110)**: **≤ 46 sin sobrecarga**, **47-55 leve**, **≥ 56 intensa**. **Abreviada de 7 ítems (7-35)**: **≥ 17 = sobrecarga intensa** (no hay categoría leve).
- **Norton** (5-20; el manual: riesgo **< 14**, muy alto **≤ 12**) y **Braden** (6-23; el manual: riesgo **≤ 16**; en el tema 53, alto riesgo **≤ 12**).

6. Coordinación sociosanitaria en Murcia

- Entre el **SMS** y el **IMAS**. El **Plan de Salud** recoge un modelo sociosanitario integrado (vulnerabilidad y cuidados de larga duración).
- **Historia sociosanitaria compartida**: los profesionales sanitarios ven las prestaciones del PIA y los sociales, las alertas de salud.
- **Modelo residencial**: valoración geriátrica al ingreso, visita de acogida con el centro de salud y coordinación con medicina interna, geriatría y salud mental.
- **Enfermera gestora de casos (EGC)**: práctica avanzada que **gestiona la complejidad** (no hace curas ni extracciones de rutina): pacientes frágiles pluripatológicos con dependencia grave; captación por datos de frecuentación y derivación; **visita domiciliaria** con **patrones de Gordon** (el más alterado: **actividad-ejercicio**),

Barthel, MEC, Zarit y Gijón; gestiona material ortoprotésico, oxígeno, absorbentes, vías rápidas y trámites urgentes con el IMAS; forma al cuidador.

7. Plan de cuidados en la dependencia

- NANDA: **Deterioro de la movilidad física**, **Déficit de autocuidado** (baño, vestido), **Riesgo de deterioro de la integridad cutánea**, **Deterioro de la eliminación urinaria**, **Riesgo de estreñimiento**, **Deterioro de la deglución** y, en el cuidador, **Cansancio del rol de cuidador**.
- NIC: cambios posturales **cada 2-4 h**, inclinación **≤ 30°**, **AGHO sin masaje**; en la **disfagia**: **espesantes** (néctar, miel, pudin), **evitar dobles texturas** (sopa de fideos, yogur con trozos), higiene oral antes y después, **comer sentado a 90°** y mantenerse incorporado **a 45° unos 45 min** después; educación del cuidador en movilizaciones y comunicación con el paciente con demencia; **respiro familiar**.
- NOC: Consecuencias de la inmovilidad, Integridad tisular, **Bienestar del cuidador principal**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Ley **39/2006, de 14 de diciembre**; crea el **SAAD**; «cuarto pilar».
! Nivel **mínimo = Estado**; acordado = Estado + comunidad; adicional = comunidad.
! Autonomía = **decidir**; dependencia = **permanente**, necesita **otra persona** para las **ABVD**.
! **Grado I 1 vez/día (25-49); II 2-3 veces/día (50-74); III apoyo continuo (75-100); < 25 sin grado.**
! Prioridad de los **servicios**; teleasistencia compatible con todo **salvo residencia**.
! Cuidador no profesional: **≥ 18 años** y parentesco hasta **3.er grado** (tíos y sobrinos sí; **primos no**).
! Resolver en **6 meses**; traslado: **60 días**; revisión por **cambio de salud, error o cambio de situación**.
! BVD **≥ 3 años**, **47 tareas, 10 actividades**, observación directa; EVE **< 3 años** (1-2-3).
! **Barthel: 15 puntos solo traslado y deambulación; silla de ruedas máx. 90; < 20 total.**
! Katz **A = independiente**, **G = dependiente**; Lawton **8 ítems**, se pierden **primero**.
! MEC de Lobo **35**, corte **23/24**; Pfeiffer **cuenta errores** (≥ 3 deterioro).
! Gijón **> 15** riesgo social; Zarit **≥ 56** intensa (abreviado **≥ 17**).
! EGC = **gestión de la complejidad**, no cuidados de rutina; patrón más alterado: **actividad-ejercicio**.
! Disfagia: **sin dobles texturas**, espesantes, **90°** al comer y **45° durante 45 min** después.